

ナ ファ モ ス タ ッ ト

はじめに

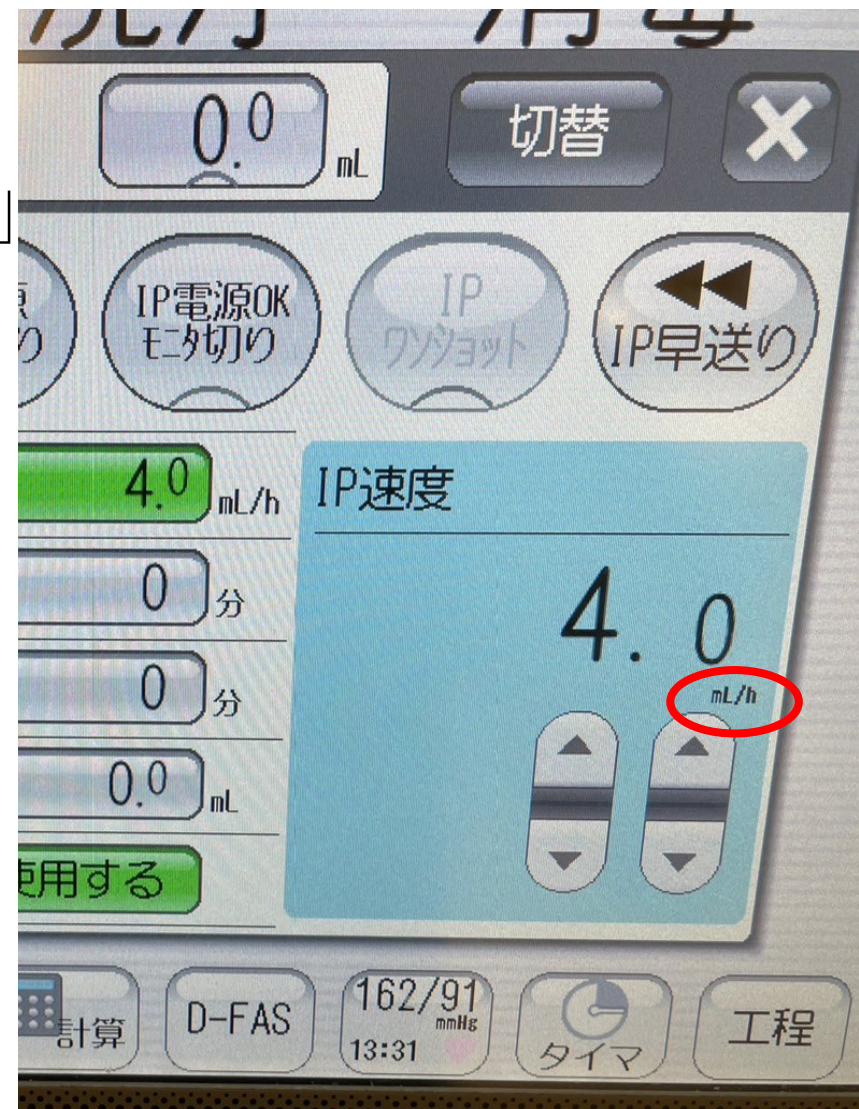
医師からは、

「ヘパリン初回〇〇単位、持続〇〇単位、カット無し」
「ナファモスタット〇〇mg/hr」という指示が出る。

しかし、コンソールでは〇〇ml/hrという設定。

医師も〇〇ml/hrで指示出してくれたら
楽やのに…と最初は思った。

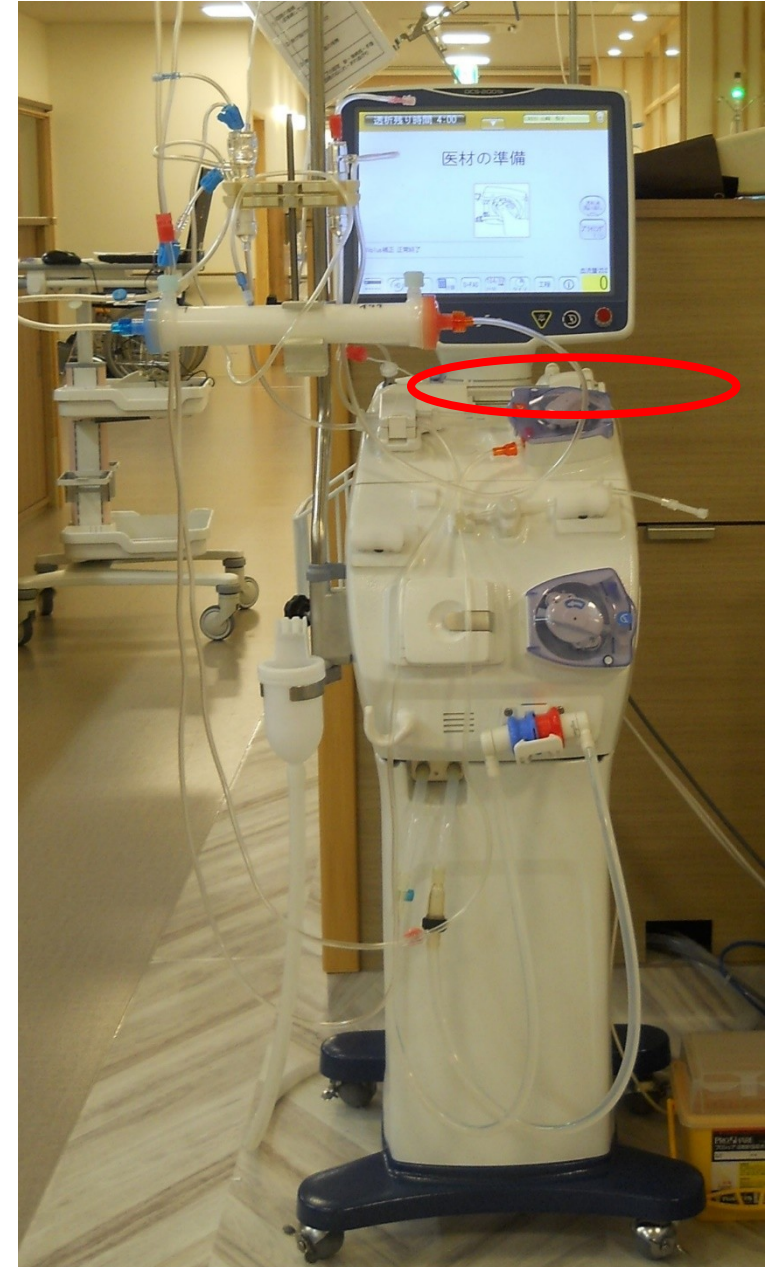
※IP : infusion pump→薬液注入ポンプ



みたきのヘパリン 青:250単位/1ml
→初回1000単位の指示であれば4ml入れればよい。
ヘパリンは元々液体のため、
そのままコンソールのIPにシリンジをセットできる。

対して、ナファモスタットは粉末。
→自分で溶かして液体にしなければ
コンソールにセットできない。

溶かす液体の量を決めておかないと
濃度が毎回変わってしまう。



みたきでは

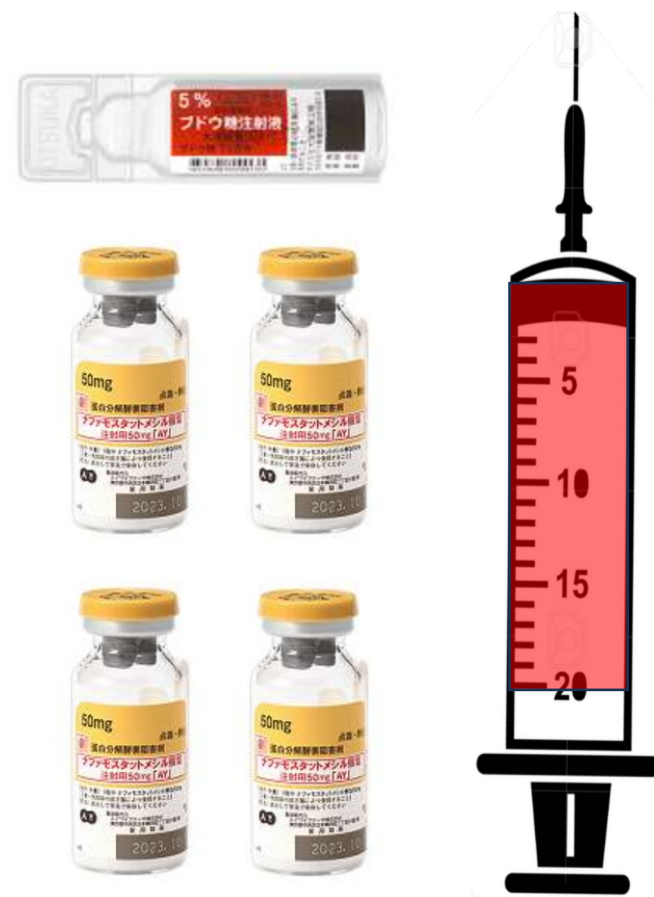
1mlに10mg溶解する。

とルールで決めている。

つまり20mlのブドウ糖液なら
ナファモスタットを200mg溶解する必要がある。

ナファモスタットは1Vに50mgなので4V必要。

**ナファモは
5%ブドウ糖液で
溶解すること！！**



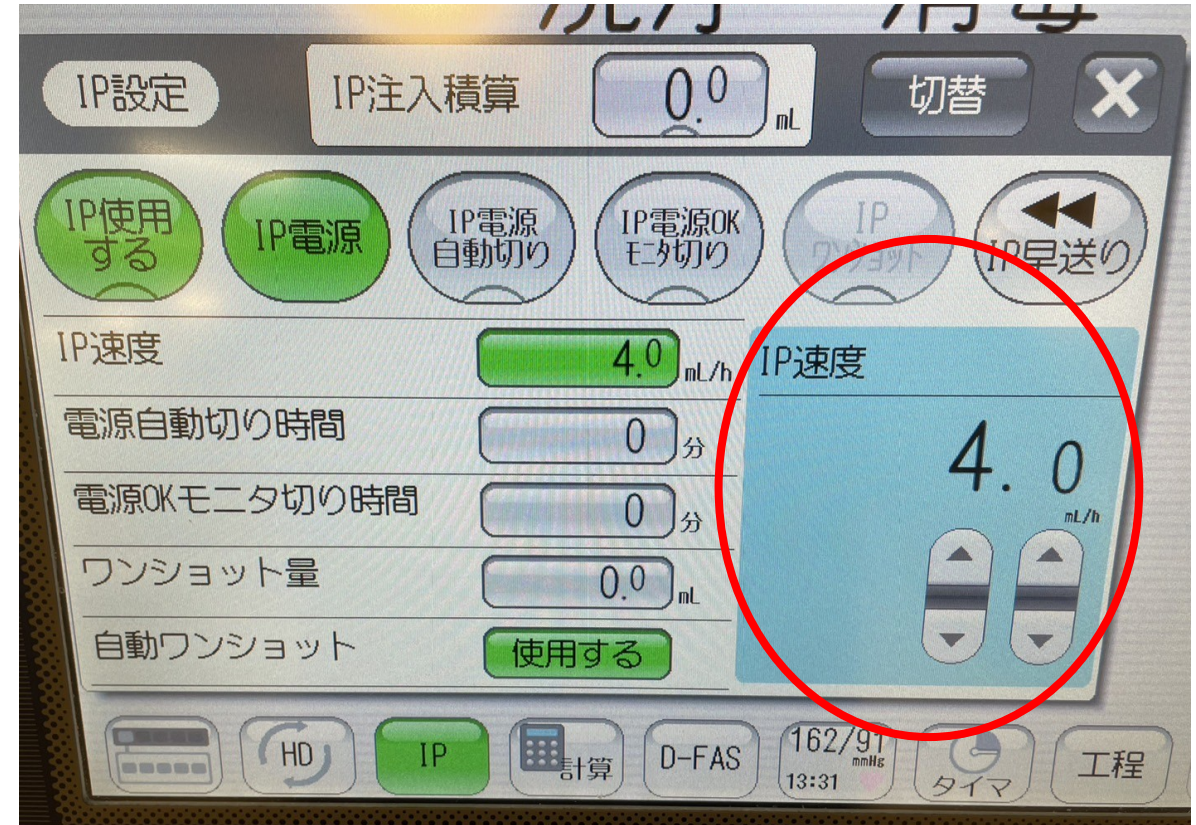
医師指示は「ナファモスタット40mg/hr」が多い。

みたきでは1mlに10mg溶解する。

1時間に4ml投与する設定にすれば
40mg入っていることになり、指示通り。

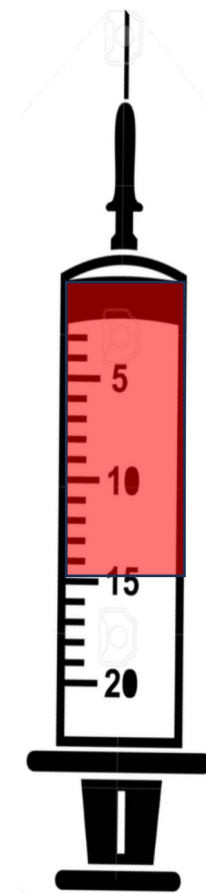
透析時間が4時間であれば
 $40 \times 4 =$ 合計160mg必要。
4V (200mg) 用意する。

3時間であれば
 $40 \times 3 =$ 合計120mg必要。
3V (150mg) あれば足りる。



ただし、1mlに10mg溶解する。というルール上、
3V（150mg）を溶解する場合、15mlで溶解する！

いつも4Vを20mlで溶解しているため、
その流れで3Vを20mlで
溶解してしまったスタッフがいた。



万が一、溶解する量を間違えた場合の対応。

IP速度をその日のみ調整すればOK。

イメージ

本当は15mlのところ、20mlで溶解してしまった。

→いつもより薄まっている。

→いつもより多く入れなければならない。

ポイント！！！！

まず1mlあたり何mgなのか？を計算。



医師指示の〇〇mgを入れるためには
何ml/hrでIP設定すればよいか？を計算すればよい。

最後に

ml/hrで指示受けすると、
緑ヘパリン（500単位/ml）と青ヘパリン（青250単位/ml）
どっちを使うかによって体内に入る量が変わってしまったり
ナファモスタットだと溶解する液量によって濃度が変わる。
→やっぱりミスの少ない指示は、単位もしくはmgである！と。

**コンソールを操作するのは看護師とME。
医師の指示通りにIP設定を行わなければならない。**